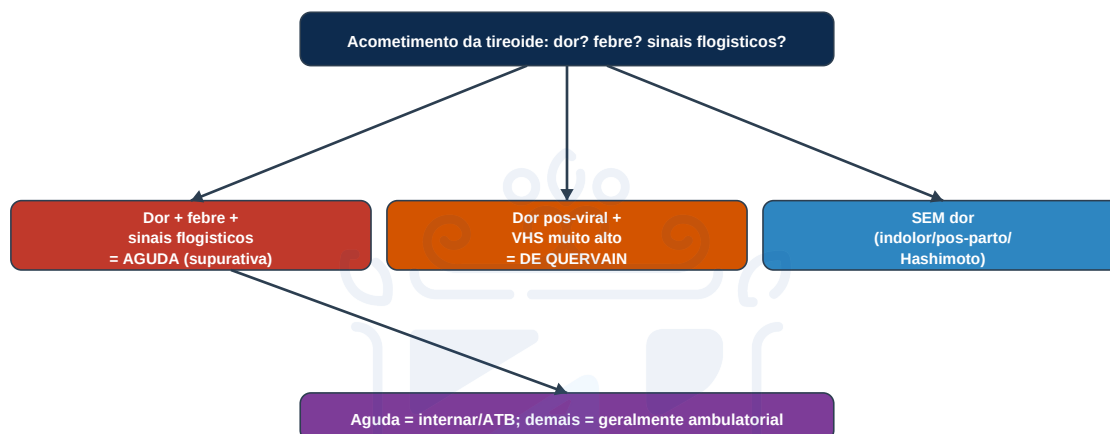


# TIREOIDITES — DIFERENCIAR PARA TRATAR

## FLUXOGRAMA — DOR CERVICAL E TIREOIDE

### TIREOIDITE — A DOR (OU SUA AUSÊNCIA) ORIENTA



## DEFINIÇÃO

### O QUE É

- Processo inflamatório da tireoide, de etiologia bacteriana, viral ou autoimune
- Classificação por tempo de evolução e causa: aguda, subaguda e crônica
- A presença e o tipo de DOR são o principal divisor clínico no PS
- Muitas cursam em 4 fases: hiper -> eu -> hipo transitório -> recuperação

## TIPOS DE TIREOIDITE — QUADRO E LABORATÓRIO

| Tipo                                 | Clínica                                                                                | Laboratório / imagem                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aguda (supurativa)                   | Início súbito, doloroso, febre, sinais flogísticos, disfagia/disfonia; imunodeprimidos | Leucocitose com desvio, VHS alto; TSH/T4L normais; USG: abscesso; PAAF confirma          |
| De Quervain (subaguda granulomatosa) | Pós-viral, dor que piora à deglutição; causa mais comum de dor tireoidiana             | VHS > 50, PCR e transaminases altas; fase hiper (T4>T3, TSH baixo); cintilo hipocaptante |
| Linfocítica indolor / pós-parto      | SEM dor cervical; pós-parto/aborto; risco de hipotireoidismo definitivo                | Anti-TPO/AAT +; VHS normal; cintilo hipocaptante                                         |
| Hashimoto (crônica)                  | Autoimune; pode ter hashitoxicose; evolui p/ hipotireoidismo                           | Anti-TPO +; hipotireoidismo definitivo                                                   |
| Riedel                               | Fibrose, bócio pétreo indolor, sintomas compressivos; simula CA anaplásico             | Cintilo normal; PAAF não elucidativa; dx por biópsia a céu aberto                        |

## RED FLAGS — TIREOIDITE COMPLICADA

### ALARMES (INTERNAÇÃO/EMERGÊNCIA)

- Tireoidite AGUDA supurativa: internação MANDATÓRIA
- Sepses / infecção grave
- Insuficiência respiratória aguda / compressão de via aérea
- Dor refratária / sintomas sistêmicos intensos
- Necessidade de drenagem cirúrgica de urgência (abscesso)

## TRATAMENTO — POR TIPO

### Rx CONDUTA

AGUDA: ATB EV para *S. aureus*, *S. pyogenes*, *S. pneumoniae* (imunodeprimido: pensar fungos/*P. jirovecii*)  
+ monitorização de via aérea + drenagem cirúrgica se abscesso  
DE QUERVAIN: AINE ou corticoide para a dor; betabloqueador para sintomas adrenérgicos  
NÃO usar tionamidas (não há hiperprodução, e sim liberação por destruição)  
INDOLOR/PÓS-PARTO: betabloqueador na fase hiper; LT4 se hipotireoidismo clínico  
RIEDEL: tratamento cirúrgico; bom prognóstico

## CONCEITO-CHAVE — TIREOTOXICOSE POR DESTRUIÇÃO

### POR QUE NÃO USAR TIONAMIDAS

- Na tireoidite, o hipertireoidismo é por LIBERAÇÃO do hormônio pré-formado (destruição glandular)
- Não há síntese aumentada -> metimazol/propiltiouracila NÃO funcionam
- Cintilografia HIPOCAPTANTE confirma o mecanismo destrutivo (diferencia de Graves, que é hipercaptante)
- Tratar sintomas adrenérgicos com betabloqueador; a fase hiper é autolimitada

## INTERNAÇÃO x AMBULATORIAL

| Tipo                        | Conduta usual | Quando internar                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Aguda supurativa            | Internação    | Sempre (ATB EV, via aérea, drenagem)                  |
| De Quervain                 | Ambulatorial  | Dor incapacitante, falha terapêutica, IRpA, supuração |
| Indolor/Hashimoto/pós-parto | Ambulatorial  | Raramente (instabilidade grave)                       |

## CHECKLIST DE SEGUIMENTO

### ANTES DA ALTA AMBULATORIAL

- ☐ Excluída tireoidite supurativa / complicação de via aérea
- ☐ Dor controlada (AINE/corticoide) e sintomas adrenérgicos manejados (betabloqueador)
- ☐ Função tireoidiana solicitada para seguimento das fases
- ☐ Pós-parto com hipotireoidismo: reavaliar suspensão da LT4 após 8-12 semanas
- ☐ Retorno ambulatorial (endocrinologia) garantido

## MODELO DE TRANSFERÊNCIA — URGENTE

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com tireoidite complicada (\_\_\_ supurativa / De Quervain / tireotoxicose).
- Motivo da transferência: compressão de via aérea / abscesso cervical / instabilidade.
- Estado: \_\_\_ | SatO2 \_\_\_ | FC \_\_\_ | PA \_\_\_.
- Recurso necessário: cirurgia de cabeça e pescoço / endocrino + vaga de \_\_\_ (UTI/enfermaria).

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com dor cervical intensa após quadro viral de vias aéreas, VHS 80, fase de hipertireoidismo com cintilografia hipocaptante. Diagnóstico mais provável?

- A) Doença de Graves
- B) Tireoidite de De Quervain (subaguda granulomatosa)
- C) Tireoidite aguda supurativa
- D) Tireoidite de Riedel
- E) Bócio multinodular tóxico

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que NÃO se usam tionamidas (metimazol/PTU) na fase de hipertireoidismo da tireoidite subaguda?

- A) Porque causam agranulocitose sempre
- B) Porque o hipertireoidismo decorre de liberação do hormônio pré-formado por destruição, não de síntese aumentada
- C) Porque a cintilografia é hipercaptante
- D) Porque a tireoidite nunca causa hipertireoidismo
- E) Porque as tionamidas pioram a dor cervical

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual tipo de tireoidite tem internação mandatória?

- A) Tireoidite de Hashimoto
- B) Tireoidite linfocítica indolor
- C) Tireoidite aguda supurativa
- D) Tireoidite pós-parto
- E) Tireoidite de De Quervain não complicada

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Mulher no pós-parto com tireotoxicose indolor, anti-TPO positivo e cintilografia hipocaptante. Qual o tratamento da fase hiperadrenérgica?

- A) Metimazol em dose alta
- B) Betabloqueador para os sintomas adrenérgicos
- C) Iodo radioativo
- D) Levotiroxina imediata
- E) Tireoidectomia de urgência

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente com bócio pétreo, indolor, de crescimento progressivo, com sintomas compressivos, podendo simular carcinoma anaplásico. Qual a hipótese?

- A) Tireoidite de De Quervain
- B) Tireoidite aguda supurativa
- C) Tireoidite de Riedel (fibrosante)
- D) Tireoidite pós-parto
- E) Doença de Graves

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor tireoidiana pós-viral + VHS muito elevado + fase hiper com cintilografia hipocaptante = tireoidite de De Quervain (subaguda granulomatosa), a causa mais comum de dor na tireoide. Graves seria hipercaptante.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na tireoidite subaguda o hipertireoidismo é por LIBERAÇÃO de hormônio pré-formado pela destruição glandular — não há síntese aumentada, por isso tionamidas não funcionam. Cintilografia hipocaptante confirma. Trata-se com betabloqueador.

### QUESTÃO 3 → Resposta: C

A tireoidite aguda supurativa tem internação mandatória: exige ATB EV, monitorização de via aérea e, conforme o caso, drenagem cirúrgica de urgência. As autoimunes/subaguda são, em geral, ambulatoriais.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na tireotoxicose por destruição (pós-parto/indolor), a fase hiper é autolimitada e adrenérgica — trata-se com betabloqueador. LT4 fica para a fase de hipotireoidismo clínico; tionamidas e iodo não se aplicam.

### QUESTÃO 5 → Resposta: C

Bócio pétreo indolor, fibrosante, com sintomas compressivos, que pode simular carcinoma anaplásico, caracteriza a tireoidite de Riedel. Diagnóstico por biópsia a céu aberto; tratamento cirúrgico, com bom prognóstico.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico